PROVÃO DE M1 DO 4 ANO - 04/10/2019

M1 - Reumato/Ortop/Geri/Plást

1. Quedas são frequentes entre os idosos. Sobre as adaptações que devem ser realizadas para preveni-las, marque a opção correta:

a) Uso de barras de apoio no vaso sanitário para que facilitem o ato de sentar e levantar.
b) Preferência pelo uso de sandálias e chinelos por serem mais fáceis de colocar e tirar e se adaptam melhor aos pés.
c) Subir em pequenos bancos (tamboretes) para pegar coisas em locais mais altos, evitando-se assim o esforço de esticar os braços.
d) Diminuir um pouco a iluminação dos cômodos mais usados na casa para evitar o ofuscamento.

2. - Homem de 85 anos em uso de 6 medicamentos para tratamento de glaucoma, hipertensão arterial e depressão é atendido no pronto-socorro com história de que há 72 horas apresentava inversão de padrão do sono, desorientação e fraqueza. Há 24 horas está muito sonolento, não querendo alimentar-se. Foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Ao exame clínico, apresentava-se sonolento, desorientado, com FR de 28 irpm, FC de 88 bpm, PA de 110/70 mmHg, temperatura de 36,9º, $SatO_2$ de 90% em ar ambiente, RCR, sem sopros, pulmões com estertores finos na base direita, abdome e membros sem alterações, pupilas isocóricas e fotorreagentes, tônus e força muscular normais, reflexos presentes e simétricos.

Escala de Glasgow:

	Avaliação	Pontuação
. Abertura ocular	Espontânea	4 pontos
	Por Estimulo Verbal	3 pontos
	Por Estimulo A Dor	2 pontos
	Sem Resposta	1 ponto
. Resposta verbal	Orientado	5 pontos
	Confuso (Mas ainda responde)	4 pontos
	Resposta Inapropriada	3 pontos
	Sons Incompreensíveis	2 pontos
	Sem Resposta	1 ponto
. Resposta motora	Obedece Ordens	6 pontos
	Localiza Dor	5 pontos
	Reage a dor mas não localiza	4 pontos
	Flexão anormal – Decorticação	3 pontos
	Extensão anormal - Decerebração	2 pontos
	Sem Resposta	1 ponto

Pontuação: 12

Qual é o diagnóstico mais provável?

a) Delirium
b) Depressão
c) Demência
d) Acidente vascular cerebral

3. - Mulher de 68 anos, sem capacidade funcional, que não usava medicamentos regularmente, recebeu diagnóstico de hipertensão, sendo prescrita Hidroclorotiazida 25 mg pela manhã. Desde então, a paciente passou a ir mais vezes ao banheiro, algumas delas precedidas por perda urinária de pequena monta. Incomodada com essas perdas, ela procura outro serviço médico. Com o relato de incontinência urinária, é feita a prescrição de anticolinérgico para contrações não inibidas do músculo detrusor (Oxibutinina) na dose de 5 mg/dia. Poucos dias depois, a paciente apresenta insônia com períodos de confusão mental e agitação. A filha, preocupada, leva a mãe em um pronto-socorro, onde é submetida a tomografia de crânio e radiografia do tórax, além de realizar hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, sendo que todos os resultados são normais. O médico do pronto-socorro prescreve clonazepam para a insônia e agitação. A paciente piora, fica muito agitada a noite e pela manhã fica muito sonolenta. A filha então a leva de volta a o primeiro médico, que, entendendo o ocorrido, suspende todas as medicações, com reversão do quadro em 72 horas. Com base no caso apresentado, assinale a alternativa que indica o fenômeno pelo qual a paciente passou:

a) Polifarmácia
b) Prescrição em cascata
c) Superdosagem
d) Interações medicamentosas

4. - Homem de 88 anos com demência avançada, se encontra acamado a mais de 2 anos, tendo tido 4 internações por pneumonia no último ano, foi internado hoje devido a outro quadro de pneumonia, tendo uma queda grave do estado geral. Qual seria a conduta mais adequada para o paciente em questão?

a) Entubar paciente e dar droga vasoativa
b) Iniciar antibiótico, mandar paciente para UTI e depois avisar a família do ocorrido
c) Conversar com a família sobre o prognóstico reservado do paciente, esclarecendo que há uma doença incurável e oferecer cuidados paliativos ofertando conforto ao paciente.
d) Conversar com a família para que eles definam as condutas (inclusive as invasivas) e orientar a equipe a seguir as vontades da família

5. - Sobre a gastrostomia em pacientes com demência avançada.
a) A gastrostomia é sempre um procedimento indicado
b) Deve ser feita para evitar quadros de pneumonia devido a aspiração.
c) É indicada pois previne úlceras por pressão
d) Não deve ser indicada, pois não previne pneumonia, não melhora a nutrição e não previne úlceras de pressão

6. - Uma filha chega com a mãe analfabeta em seu consultório, referindo que a mãe anda meio esquecida. A mãe refere que anda mesmo desatenta, e que não quer mais sair de casa, pois anda muito desanimada. A mãe apresentou pontuação normal em todos os testes com exceção no teste de escala para depressão o qual apresentou 7 pontos. Sobre o caso exposto podemos afirmar:
a) Paciente tem demência
b) A paciente tem a possibilidade de ter depressão
c) A paciente tem alzheimer pois ela apresentou baixa pontuação no MEEM (Ela deu a pontuação do MEEM, era 22)
d) A paciente está apenas com um quadro de envelhecimento normal

7. - Assinale a alternativa correta que descreva o uso medicações inapropriadas em pacientes idosos.
a) Betabloqueador em idosos com insuficiência cardíaca
b) Benzodiazepínicos em idoso com síndrome demencial
c) Antipsicóticos em baixas doses em idosos com delirium
d) Diuréticos tiazídicos para hipertensão arterial em idosos funcionais

8. - Sobre a síndrome de fragilidade, é correto afirmar que:
a) O número de doenças crônicas que define se o idoso é portador de fragilidade
b) A incapacidade funcional é a principal causa de fragilidade, pois todos idosos frágeis são incapazes
c) A polifarmácia é um fator de risco independente da a síndrome de fragilidade
d) Dentre os critérios do fenótipo de fragilidade de Fried a presença do déficit cognitivo é o mais importante

9. - Sexo feminino 82 anos queixa-se de fraqueza, dificuldade de subir escadas e carregar um saco de arroz. Refere também que tem tido dificuldades para levantar-se de uma cadeira e apresentou 2 quedas sem maiores consequências nos últimos 6 meses. No exame clínico, foi solicitada a sentar-se e levantar-se de uma cadeira 5 vezes seguidas. Gastou 38 segundos para fazer isso. Com base nos dados, qual é o diagnóstico que pode ser feito?
a) Sarcopenia definida
b) Síndrome de fragilidade
c) Provável sarcopenia
d) Provável fragilidade

10. - Ainda sobre o caso anterior, qual será o próximo passo a ser realizado para o diagnóstico?
a) Medir força de preensão plantar
b) Medir velocidade de marcha
c) solicitar dosagens de vitaminas
d) quantificar a massa muscular

11. - Sobre a cicatrização por segunda intenção, assinale a alternativa verdadeira:
a) Ela se verifica quando ocorre aproximação direta das bordas da ferida
b) Ela favorece o processo de remodelagem cicatricial
c) Normalmente ocorre nas lesões em que havia a presença prévia de infecção local, que após ser debelada, apresenta condições de fechamento
d) Ela ocorre quando a cicatrização acontece por processo biológico natural, sem síntese cirúrgica

12. - Na Displasia de Desenvolvimento do Quadril;
a) O teste de Barlow é a manobra que detecta a luxação do quadril. Esta manobra é executada realizando a flexão e adução do quadril.
b) O teste de Galleazzi é sempre anormal mesmo na presença dessa patologia nos quadris bilateralmente
c) Independente da idade da criança, não deve ser realizado tratamento cirúrgico.
d) O calção gessado é sempre usado nas luxações teratológicas do quadril.

13. Paciente feminina de 25 anos de idade, chega ao pronto socorro com queimadura de 2º grau por causa de uma combustão de álcool com 35% da superfície corporal queimada. Qual a sequência lógica no atendimento inicial dessa paciente?

a) Acesso venoso - reposição com ringer lactato - curativo - sonda nasogástrica - analgesia intramuscular - profilaxia para tétano

b) Analgesia endovenosa - avaliar vias aéreas - acesso venoso - reposição com soro glicosado - curativo - sonda nasogástrica

c) Avaliar vias aéreas - acesso venoso - reposição com soro ringer lactato - avaliar lesões associadas - analgesia endovenosa - sonda vesical

d) Oxigênio a 100% - analgesia intramuscular - acesso venoso - antibiótico - profilaxia para tétano - curativo

14. Em relação ao osteossarcoma, marque a alternativa correta:

a) É o tumor ósseo benigno mais comum

b) Acomete mais frequentemente a diáfise de ossos tubulares curtos

c) Acomete mais frequentemente a metáfise de ossos longos e o RX é com bordas mal definidas

d) No RX simples, os bordos são bem definidos

15. Paciente com escoliose idiopática do adolescente com Cobb entre T5 e T11 de 91 graus. Sobre a história natural dessa deformidade, marque a alternativa correta:

a) Paciente com maior risco de desnutrição pelo menor volume abdominal

b) Pela deformidade tridimensional há uma deformidade do tórax com maior risco de síndrome restritiva pulmonar

c) Como a curva é de pequena magnitude o paciente apresenta vida normal e não requer tratamento

d) O ângulo de Cobb nada influencia a gravidade do caso e sim a localização da curva e idade do paciente

16. Qual o nervo mais utilizado para a enxertia nervosa?

a) Fibular

b) Sural

c) Safeno

d) Auricular posterior

17. Tumor músculo-esquelético osteolítico mais frequente na diáfise em crianças, com semelhança a osteomielite, por apresentar reação periosteal em casca de cebola:

a) Osteossarcoma

b) Condrossarcoma

c) Sarcoma de Ewing

d) Osteoblastoma

18. Paciente de 18 anos de idade, vítima de acidente automobilístico. Atendido no PS, onde foi feito em diagnóstico de fratura da diáfise do úmero, simples, fechada e com desvio angular em antecurvado. O vértice da mesma é:

a) Anterior

b) Medial

c) Lateral

d) Posterior

19. - Paciente sexo masculino 18 anos, vítima queda de 5 metros, está desacordado e com sangramento abundante em face:

a) Prioridade neste caso é avaliar a fratura de face, devido ao sangramento e risco de choque hipovolêmico

b) Como ele está desacordado, não se deve preocupar com estabilidade da coluna, pois rebaixamento nível de consciência é mais grave

c) Devemos suspeitar de trauma em coluna cervical quando existe trauma de face, TCE, intoxicação alcoólica ou em pacientes comatosos

d) Se este paciente apresentar Babinsky e Hoffman positivos é provável que tenha trauma raquimedular lombar

20. - Paciente sexo masculino, 42 anos, sedentária, vem apresentando lombalgia há 3 meses. A dor piora a movimentação, não tem irradiação, nega alterações esfincterianas, perda de peso, febre ou déficit de força. A conduta deve ser:

a) Solicitar Ressonância da coluna lombar por ter essa queixa de forma persistente e crônica

b) Encaminhar a reabilitação para reeducação neuromuscular e orientações ergonômicas de vida

c) Prescrever AINE e miorrelaxante por 6 semanas

d) Provavelmente se trata de hérnia discal pela característica da dor

21. - Homem, 36 anos, atleta profissional, diagnosticado com síndrome de impacto do ombro esquerdo. Paciente refere dor no referido ombro há 8 meses, após atividade de elevação do MMSS. Dor a rotação interna a se vestir e dor noturna no decúbito ipsilateral. Diagnósticos diferenciais:

a) Capsulite adesiva e tendinite calcária fase crônica

b) Subluxação glenoumeral e hérnia discal cervical

c) Radiculopatia cervical e neoplasma

d) Rotura completa do tendão supraespinhal e artrose acromioclavicular

22. - Mulher, 84 anos, aguarda consulta com reumatologista para avaliação de dor constante no joelho esquerdo, de aparecimento há um mês, após queda da própria altura. Após a avaliação clínica, o médico solicita uma USG do joelho e encaminha a paciente para a consulta com a geriatria, com suspeita de “síndrome do idoso caidor”. Nesse caso, para a suspeita da referida síndrome, o médico reumatologista deve ter encontrado, durante a consulta, a seguinte característica:

a) Barthel = 90 pontos

b) SARC-F = 6 pontos

c) Antecedentes de duas quedas em um período de doze meses.

d) Antecedentes de uma queda com fratura grave em um período de dois anos.

23. - A Osteoporose é uma desordem osteometabólica caracterizada por fragilidade óssea e predisposição a fraturas. Em pacientes com osteoporose sem fratura, a abordagem fisioterápica preventiva deve preferencialmente incluir:

a) Hidroterapia

b) Alongamentos

c) Cinesioterapia global com impacto

d) Cinesioterapia localizada sem impacto

24. - A fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa crônica, presente em aproximadamente 2,5% da população brasileira, predominando entre mulheres de 35 a 44 anos. Segundo as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia (2017) para o diagnóstico desta enfermidade, é verdadeiro:
a) A termografia é um método válido para diagnóstico da FM, exceto em pacientes portadores de hipertensão arterial.
b) A polissonografia pode ser utilizada como método diagnóstico para a FM apenas nos pacientes com insônia terminal.
c) A presença de dor difusa não é essencial para o diagnóstico em pacientes com suspeita de FM.
d) Os pontos dolorosos podem ser úteis no diagnóstico de fm quando avaliados em conjunto com outros distúrbios funcionais.

25. -Uma mulher de 62 anos comparece ao seu consultório para avaliação da reumatologia , como exames apresenta uma densitometria óssea com t-score de 2.9. Considerando isso, o diagnóstico e :

a) Osteopenia
b)Osteoporose
c) Massa óssea inadequada para a idade
d) Normal

26. - Uma das etapas importantes no exame da coluna vertebral consiste na manobra que avalia a sacroileite, denominado teste de Patrick-Fabere, que consiste na seguinte manobra sobre uma das pernas

a)flexão, abdução,rotação externa
b)extensão,abdução,rotação interna
c)extensão, abdução,rotação interna
d)flexão, adução,rotação externa

27. - S.J.U , 28 anos, vem à consulta queixando de xerostomia, xeroftalmia, poliartralgia, de joelhos, mãos e punhos. Como exames complementares trás um fator reumatoide positivo e anti ccp negativos, anti RO e anti La com títulos de 1:280. O diagnóstico correto é :
a) Artrite reumatoide
b)Síndrome de Sjogren
c)Artrite Psoriásica
d)osteoartrite

28. - Paciente de 49 anos, masculino, queixa-se de dor e edema em joelho direito há 3 dias. Relata episódios semelhantes em hálux esquerdo há 1 ano e em tornozelo direito há 5 meses. Nega febre, tosse, disúria e erupção cutânea. Exame Físico: artrite de joelho direito de joelho direito. Artrocentese evidenciando cristais em forma de agulha, com birrefringência fortemente negativa. Foi solicitado Raio-X de joelhos, porém o laudo não foi liberado. É correto afirmar:
a) Raio-x dos joelhos revela calcificação dos meniscos, confirmando diagnóstico de artrite reumatoide
b) Raio-x dos joelhos revela erosão em saca-bocado, confirmando diagnóstico de osteoartrite
c) Medicar, imediatamente, com colchicina e/ou diclofenaco
d) Medicar, imediatamente, com alopurinol ou benzobromarona

Caso clínico para as questões 29 e 30: 22 anos, estudante, *não falava o sexo,* relata dor e edema de todas IFPs bilateralmente e punhos há 4 semanas. Relata febre não aferida, inapetência e aftas orais. Queixa-se de disúria e urina espumosa. Nega dispneia e palpitação. Informa relação sexual sem proteção. Hemograma normal, VHS= 80, FR= negativo, FAN= positivo- padrão nuclear homogêneo (1/640). Raio-x de mãos e punhos normais.

29. - Quais são as possibilidades diagnósticas?

a) Osteoartrite, gota e artrite séptica
b) Artrite reumatoide, Artrite viral e osteoartrite
c) Artrite gonocócica, LES e Artrite viral
d) Artrite psorásica, Artrite gonocócica e Artrite reumatoide

30. - Quais exames pedir?

a) Ácido úrico e proteinúria de 24 horas
b) Anti-CCP e RNM das mãos
c) Punção articular e sorologia viral (hepatites, HIV e Chick)
d) Anti-DNA e proteinúria de 24 horas

31. Leia as afirmativas a seguir e selecione a alternativa correta

I - É um antibiótico peptídico, porém considerado um DMARDs não biológico.Inibe a produção dos receptores de IL-1 e IL-2 e, secundariamente, inibe a interação entre macrófagos e células T, bem como a responsividade das células T e a função das células B dependentes das células T;

II - Interfere com a síntese de purinas e é citotóxica. Principal efeito indesejável é a depressão da medula óssea;

III - É um DMARDs não biológico sintético, é metabolizada a sulfapiridina e ácido 5-aminossalicílico. A sulfapiridina é provavelmente o composto ativo no tratamento da Artrite Reumatóide;

IV - É um antibiótico macrolídeo de origem fúngica que tem um mecanismo de ação muito semelhante ao da ciclosporina;

A alternativa que correlaciona corretamente a característica descrita e o respectivo fármaco é:

32. Em relação aos AINES, marque a alternativa correta:

a) Os principais efeitos dos AINES são anti inflamatório, anti hipertensivo e anti-depressivo;

b) Naproxeno, um derivado do ácido propiônico, tem potência 20x inferior a aspirina, daí sua ineficácia clínica;

c) Os AINES tradicionais inibem tanto a COX-1 como a COX-2, embora a sua potência relativa para cada isoforma seja diferente;

d) O Paracetamol, derivado do para-aminofenol, tem uma melhor atividade anti inflamatória que antitérmica e analgésica

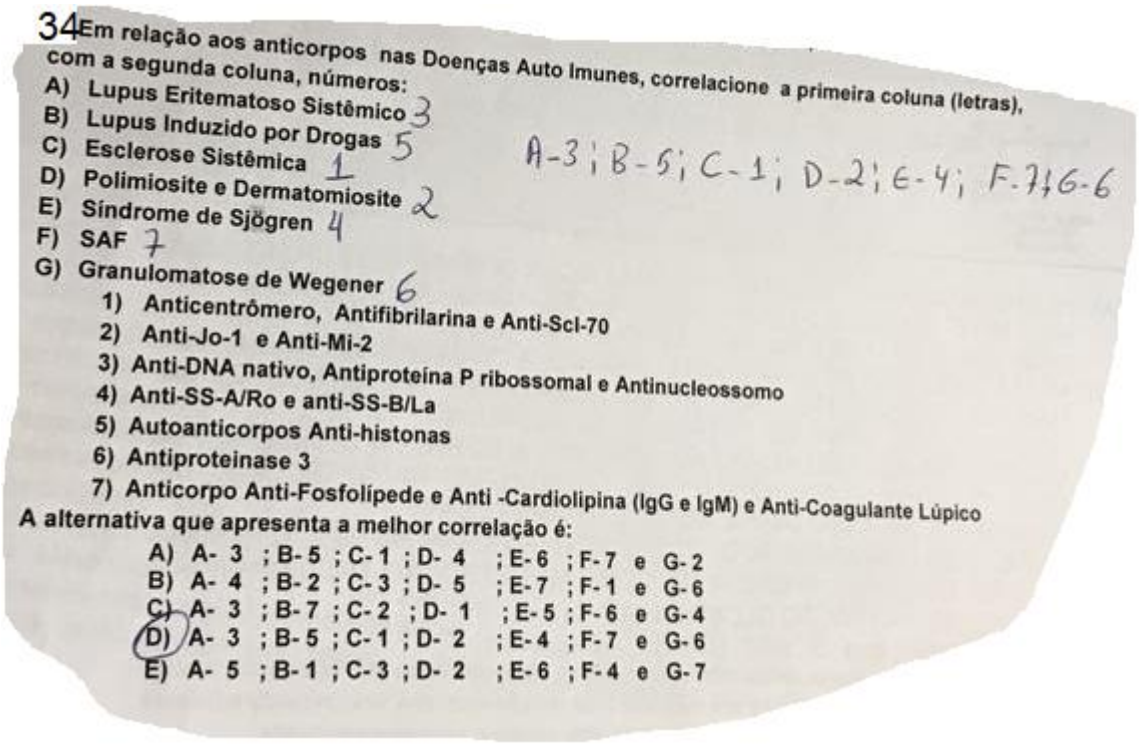
33. Em relação aos glicocorticóides, julgue os itens abaixo.

I - As alterações da hidrocortisona e da cortisona deram inicio aos potentes glicocorticoides atuais com menor retenção de sódio

II - Análogos sintéticos da hidrocortisona possuem vantagens como: maior potência antiinflamatória, ação prolongada e menor retenção de sódio

III - Acrescentando um radical hidroxila ou metil ao carbono 16 da 19-flurpredinisolona, temos a triancinolona e a betametasona, com ação glicocorticoide cerca de 30x maior que a hidrocortisona e com atividade mineralocorticoide nula;

34. -



34 Em relação aos anticorpos nas Doenças Auto Imunes, correlacione a primeira coluna (letras), com a segunda coluna, números:

A) Lupus Eritematoso Sistêmico 3
B) Lupus Induzido por Drogas 5
C) Esclerose Sistêmica 1
D) Polimiosite e Dermatomiosite 2
E) Síndrome de Sjögren 4
F) SAF 7
G) Granulomatose de Wegener 6

A-3 ; B-5 ; C-1 ; D-2 ; E-4 ; F-7 ; G-6

1) Anticentrômero, Antifibrilarina e Anti-Scl-70
2) Anti-Jo-1 e Anti-Mi-2
3) Anti-DNA nativo, Antiproteína P ribossomal e Antinucleossomo
4) Anti-SS-A/Ro e anti-SS-B/La
5) Autoanticorpos Anti-histonas
6) Antiproteinase 3
7) Anticorpo Anti-Fosfolípede e Anti -Cardiolipina (IgG e IgM) e Anti-Coagulante Lúpico

A alternativa que apresenta a melhor correlação é:

A) A- 3 ; B- 5 ; C- 1 ; D- 4 ; E- 6 ; F- 7 e G- 2
B) A- 4 ; B- 2 ; C- 3 ; D- 5 ; E- 7 ; F- 1 e G- 6
C) A- 3 ; B- 7 ; C- 2 ; D- 1 ; E- 5 ; F- 6 e G- 4
D) A- 3 ; B- 5 ; C- 1 ; D- 2 ; E- 4 ; F- 7 e G- 6
E) A- 5 ; B- 1 ; C- 3 ; D- 2 ; E- 6 ; F- 4 e G- 7

35. Laboratório de anemia no idoso

I. O exame com melhor custo/benefício e maior poder de discriminação entre anemia ferropriva e da anemia de doença crônica no idoso é a dosagem de ferro
II. O exame com melhor custo/benefício e maior poder de discriminação entre anemia ferropriva e da anemia de doença crônica no idoso é a ferritina
III. A contagem de reticulócitos é um exame muito útil para diferenciar a anemia ferropriva da megaloblástica, muito comum no idoso
IV. O sangue oculto nas fezes dever ser solicitado ao idoso se apresentar anemia microcítica e hipocrômica com anisocitose

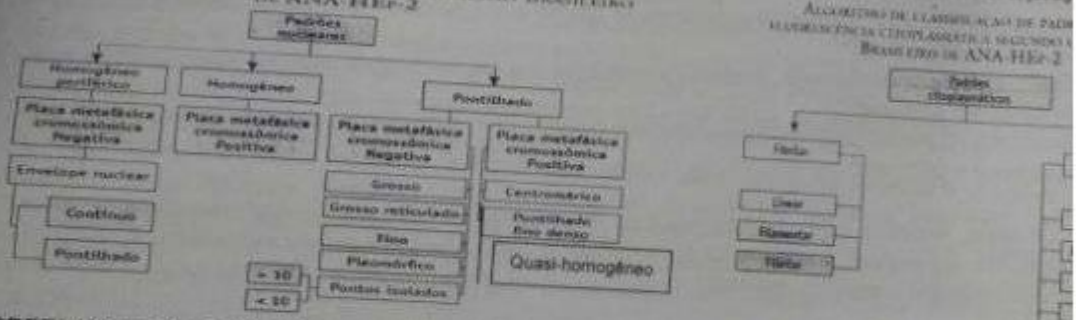
Quais afirmativas são verdadeiras?

36.

QUESTÕES

1) O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune multissistêmica crônica, cor principalmente a pele, articulações, serosas, glomérulos e o SNC. A doença é resultado da ação autoanticorpos. Em 2012, foram publicados os novos critérios de classificação do LES, denominado SLICC (*Systemic Lupus International Collaborating Clinics*). Os 11 critérios da classificação anterior (A foram substituídos por 17 critérios, sendo que é preciso ter 4 ou mais critérios, sendo pelo menos 1 imunológico, para se receber o diagnóstico de LES (http://widoctor.com.br/novos-criterios-diagnosticos-para Dentre os imunológicos, temos o Exame denominado FAN. Nas reuniões de Consenso Nacional de Laudos Células HEP2, foram criados estes algoritmos: (Bellavance e cols. mod. Rev Bras Reumatol, v. 47, n.4, p. 265-275, jul/ag

ALGORITMO DE CLASSIFICAÇÃO DE PADRÕES DE FLUORESCÊNCIA NUCLEAR SEGUNDO O CONSENSO BRASILEIRO DE ANA HEp-2



CORRELACIONES AS COLUNAS (A e B) E ESCOLHA A ALTERNATIVA CORRETA:

C) PADRÕES NUCLEARES EM CÉLULAS HEP2

I- Nuclear Homogêneo periférico, Placa metafásica cromossômica negativa, tipo membrana nuclear c

II- Nuclear Homogêneo, Placa metafásica cromossômica positiva

III- Nuclear Pontilhado, Placa metafásica cromossômica positiva, Centromérico

IV- Nuclear Pontilhado, Placa metafásica cromossômica positiva, Pontilhado Fino Denso

V- Nuclear Pontilhado, Placa metafásica cromossômica negativa, Grosso

VI- Nuclear Pontilhado, Placa metafásica cromossômica negativa, Fino

D) RELEVÂNCIAS CLÍNICAS POR AUTOANTICORPOS MAIS IMPORTANTES:

1- Anticorpo anti-proteína p 75 kDa, Ag LEDGF/p75 (lens epithelium-derived growth factor). Não esta a doença autoimune. Pode ser encontrado na Cistite Intersticial, Tumor de Mama, Processos inf inespecíficos, pode ser encontrado em indivíduos saudáveis, Dermatite Atópica, Psoríase e Asma

2- Anticorpo anti-DNA nativo: Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). **Anticorpo anti-Histona**: LES i drogas(hidralazina, procainamida, isoniazida e clorpromazina); LES idiopático. **Anticorpo anti**

(DNA/Histona, nucleossomo): Artrite Reumatóide (AR); Artrite Idiopática Juvenil, importante associação com u forma oligoarticular, Síndrome de Felty; Cirrose Biliar Primária

3- Anticorpo anti-SSA/Ro: Ag - 4 pequenos RNAs associados a 2 proteínas de 60 e 52Kd A de 60 Kd - Lupu SS: A de 52 Kd SS, ES, Miosite, LES,DMTC, AR, CBP, HAI, HVB, HVC. Ocorre na maioria dos pacien Síndrome de Sjögren (88 a 98%), Artrite reumatóide (24 a 60%), Lupus associado a fotossensibilidade em jovem, Lupus neonatal (90%), bloqueio cardíaco congênito

Anticorpo anti-SSB/La: Lúpus neonatal, LES, SS. Ag - proteína 48KD, parece ter função com fator ter transcrição da RNA polimerase III. Frequentemente associado a SSA/Ro. SS primária (71 a 87%), Lupus neonata incluindo BCC (30 a 40%), Lupus (9 a 35%). SS está associado a púrpura, hipergamaglobulinemia, disfunção se glândula salivar, edema de parótida, altos níveis de fator reumatóide, linfopenia e leucopenia

Anticorpo anti-Mi-2: Dermatomiosite, embora raramente ocorra na polimiosite do adulto.

4- Anticorpo anti-Lamina, Componente da membrana interna, pontos de ancoragem de cromossomos de célu interfase, pode ser encontrado nas Hepatites auto-imunes, raramente associado a doenças reumáticas (algumas de LES e esclerodermia linear, vasculite cerebral ou cutânea)

5- Anticorpo anti-centrômero: Esclerose Sistêmica forma CREST(curso benigno e prolongado). Esclerodermia 82%), Cirrose Biliar Primária(8%)

6- Anticorpo anti-Sm: 99% de especificidade para Lupus. Relação com doença ativa independente do título, re mais frequente com acometimento do SNC, doença renal, fibrose pulmonar e pericardite. **Anticorpo anti-RNP**: M casos associados a Sm. Critério obrigatório no diagnóstico da Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC- relaciona altos títulos), também ocorre no LES (30 a 40% doença menos severa). Esclerose Sistêmica (ES) e AR.

A SEQUÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CORRETA É:

A) I- 1 ; II- 5 ; III- 6 ; IV- 4 ; V- 3 ; VI- 2

B) I- 4; II- 2; III-1; IV- 6; V-5 ; VI- 3

C) I- 1; II- 6; III- 5; IV- 2; V- 4; VI- 3

D) I- 4; II-1; III-5 ; IV-2 ; V-3; VI- 6

E) I- 4 ; II- 2 ; III- 5 ; IV- 1 ; V- 6 ; V

37. - Paciente feminino, 25 anos, tumor epífise da tíbia. Rx: limites nítidos, fino trabeculado ósseo. Macroscopia: grande volume, lesão densa, avermelhada com lacunas hemorrágicas. Microscopia: tecido osteóide, células gigantes multinucleadas, alta vascularização. Qual o diagnóstico menos provável?
a) Tumor de células gigantes
b) Cisto ósseo aneurismático
c) Tumor marrom de hiperparatireoidismo
d) Osteossarcoma osteoblástico

38. - Em relação ao sarcoma:
a) No peritônio apresenta diagnóstico tardio,
b) É mais frequente em crianças do que em idosos e adultos
c) Linfonodo como sítio de metástase mais frequente
d) Cérebro como sítio de metástase mais frequente

39. - Paciente feminino,60 anos, 5 nódulos de 5 cm na coxa, superficiais e sem invasão neurovascular ao USG. Diagnóstico mais provável:
a) Lipoma
b) Hemangioma
c) Rabdomiossarcoma
d) Osteoma

40- A osteoartrite é uma alteração extremamente prevalente que ocorre na estrutura articular. com relação a esse assunto, assinale a correta:
A)rarefação Óssea periarticular é um achado de imagem fortemente sugestivo desse diagnóstico
B) osteófitos são achado de imagem que favorece o diagnóstico
C) sinovite e erosões marginais são achados muito sugestivos de osteoartrite
D) anormalidades do alinhamento ósseo como geno varo não estão associados à osteoartrite

41. Assinale a opção correta acerca da osteomielite
A) abscesso de Brodie caracteriza o estágio agudo da doença
B) abscesso de Brodie está localizado na cortical
C) sequestro ósseo caracteriza estágio crônico da osteomielite
D) reação periosteal e um achado de imagem patognomônico desta condição

42. assinale a opção incorreta acerca da osteomielite
A)Os achados de imagem do tipo rarefação óssea mal definidas são precocemente identificados nos exames radiográficos (primeiras 24h)
B) as metáfises são comumente acometidas e as fises abertas sao barreiras mecânicas para a disseminação do processo infeccioso para as epífises
C) a osteomielite pode ser causada por algumas condições, entre elas amigdalite, furúnculos, e infecções respiratórias e do trato urinário que se disseminam por via hematogênica
D) entre os agentes causadores mais frequentes estao: S. aureus, P. mirabilis, P. aeruginosa e E. coli

GABARITO COMENTADO | PROVÃO M1 — OUTUBRO/2019

Reumatologia · Ortopedia · Geriatria · Cirurgia Plástica | Resolução crítica independente das marcações e do gabarito preexistentes.

Critérios de leitura

As páginas originais de questões foram preservadas com todas as imagens. A última página do PDF recebido, contendo somente o gabarito preexistente, foi removida. Nos itens em que faltam opções ou há defeitos de transcrição, informa-se a limitação sem inventar alternativas. Asterisco (*) indica ressalva técnica; “SEM ÚNICA” indica alternativa não unívoca.

Gabarito resumido

01 A	**02** A	**03** B	**04** C	**05** D	**06** B	**07** B
08 C	**09** C	**10** D	**11** D	**12** A*	**13** C	**14** C
15 B	**16** B	**17** C	**18** A	**19** C	**20** B	**21** SEM ÚNICA
22 C	**23** C*	**24** D	**25** D*	**26** A	**27** B	**28** C
29 C	**30** D*	**31** SEQUÊNCIA	**32** C	**33** I e II	**34** D	**35** II apenas*
36 E*	**37** D*	**38** A	**39** A*	**40** B	**41** C	**42** A

Questões que exigem ressalvas

12: manobra de Barlow descrita de modo incompleto; **21:** mais de um conjunto de diagnósticos diferenciais plausível; **25:** T-score **+2,9** no texto, sem sinal negativo; **31 e 33:** opções não transcritas; **35:** recomendação antiga sobre sangue oculto não é obrigatória; **36:** fotografia cortada lateralmente; **42:** alternativa D generaliza agentes etiológicos. Também há ressalvas específicas nas questões 7, 23, 30, 37 e 39.

Comentários por alternativa

QUESTÃO 01 | Prevenção de quedas no domicílio

Gabarito técnico: A

Alternativa A: Correta. Barras de apoio firmemente instaladas junto ao vaso sanitário auxiliam transferências e reduzem quedas.

Alternativa B: Incorreta. Chinelos e sandálias soltas aumentam escorregões; preferir calçados fechados, ajustados e antiderrapantes.

Alternativa C: Incorreta. Subir em bancos ou tamboretes eleva o risco de desequilíbrio; objetos frequentes devem ficar acessíveis.

Alternativa D: Incorreta. Iluminação insuficiente piora identificação de obstáculos; recomenda-se iluminação adequada e sem ofuscamento.

Fundamentação principal: R1.

QUESTÃO 02 | Delirium hipoativo / misto

Gabarito técnico: A

Alternativa A: Correta. Desorientação e alteração aguda do ciclo sono-vigília em 72 horas, com sonolência, sugerem delirium; hipoxemia e possível infecção são precipitantes.

Alternativa B: Incorreta. Depressão costuma ter curso mais prolongado e não explica tão bem a instalação abrupta e a alteração do nível de consciência.

Alternativa C: Incorreta. Demência é tipicamente progressiva e crônica; pode predispor a delirium, mas não explica isoladamente a mudança súbita.

Alternativa D: Incorreta. Sem déficit neurológico focal descrito, AVC é menos provável, embora deva ser investigado se surgirem sinais sugestivos.

Ressalva: A imagem da escala de Glasgow no original foi preservada: abertura ocular 3 + resposta verbal 4 + motora 5 = 12, dado que reforça alteração de consciência, sem determinar sozinho a etiologia.

Fundamentação principal: R1.

QUESTÃO 03 | Prescrição em cascata

Gabarito técnico: B

Alternativa A: Incorreta como resposta principal. Há múltiplos fármacos, mas o fenômeno central é tratar efeitos adversos de medicamentos como novas doenças.

Alternativa B: Correta. Hidroclorotiazida desencadeou sintomas urinários; oxibutinina causou confusão; clonazepam agravou sedação/agitação.

Alternativa C: Incorreta. Não há demonstração de doses acima das prescritas ou de superdosagem.

Alternativa D: Incorreta como classificação principal. Interações podem ocorrer, mas a sequência de novas prescrições por efeitos adversos define cascata.

Ressalva: O caso exige revisar medicamentos antes de acrescentar fármacos.

Fundamentação principal: R1.

QUESTÃO 04 | Objetivos de cuidado em demência avançada

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta como rotina. Intubação e vasopressores podem ser desproporcionais conforme prognóstico, desejos e objetivos de cuidado.

Alternativa B: Incorreta. Instituir medidas invasivas e avisar só depois retira a participação adequada da pessoa/representantes na decisão.

Alternativa C: Correta. Comunicar prognóstico, discutir preferências e oferecer cuidado paliativo focado em conforto, sem excluir intervenções proporcionais.

Alternativa D: Incorreta. A família participa como representante quando aplicável, mas não substitui automaticamente a vontade prévia do paciente nem o juízo clínico.

Ressalva: Cuidados paliativos não significam abandono; antibióticos ou internação podem ser discutidos conforme benefício esperado e metas individuais.

Fundamentação principal: R2.

QUESTÃO 05 | Gastrostomia em demência avançada

Gabarito técnico: D

Alternativa A: Incorreta. A sonda não é sempre indicada; deve-se avaliar objetivos, benefícios e danos.

Alternativa B: Incorreta. Alimentação por gastrostomia não elimina aspiração de secreções ou refluxo e não demonstrou prevenir pneumonia aspirativa.

Alternativa C: Incorreta. Não há evidência de prevenção de lesões por pressão; pode haver aumento do risco.

Alternativa D: Correta no contexto de demência avançada. Não há benefício consistente em prevenção de pneumonia, melhora clínica nutricional/sobrevida ou prevenção de lesões por pressão.

Ressalva: Preferir alimentação oral assistida e adaptada quando possível. A formulação sobre «não melhora a nutrição» refere-se a desfechos clínicos, não à impossibilidade de fornecer calorias pela sonda.

Fundamentação principal: R3.

QUESTÃO 06 | Humor deprimido e queixa cognitiva

Gabarito técnico: B

Alternativa A: Incorreta. Não há perda funcional cognitiva progressiva suficiente para diagnosticar demência.

Alternativa B: Correta. Desânimo, retraimento e escore aumentado na escala de depressão geriátrica sugerem investigar depressão.

Alternativa C: Incorreta. MEEM 22 isolado, sobretudo em pessoa analfabeta, não diagnostica Alzheimer; é preciso interpretar escolaridade e função.

Alternativa D: Incorreta. Mudanças de humor clinicamente relevantes não devem ser atribuídas automaticamente à idade.

Ressalva: O escore 7 sugere rastreio positivo se a escala utilizada for a GDS-15, mas o enunciado não especifica sua versão.

Fundamentação principal: R1.

QUESTÃO 07 | Medicamentos potencialmente inapropriados

Gabarito técnico: B

Alternativa A: Incorreta. Betabloqueadores específicos são tratamento prognóstico recomendado na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

Alternativa B: Correta. Benzodiazepínicos tendem a elevar risco de quedas, delirium e piora cognitiva em pessoas com demência.

Alternativa C: Imprecisa como prática generalizada. Antipsicóticos não são de rotina no delirium; só excepcionalmente, por breve período, diante de risco grave e após medidas não farmacológicas.

Alternativa D: Incorreta. Tiazídicos podem ser apropriados no tratamento da hipertensão em idosos, com atenção a eletrólitos e hipotensão.

Ressalva: A questão poderia ter redação mais precisa: antipsicóticos também podem ser inapropriados se prescritos rotineiramente para delirium.

Fundamentação principal: R4.

QUESTÃO 08 | Fragilidade e fatores associados

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Comorbidades se associam à fragilidade, mas sua contagem não define a síndrome.

Alternativa B: Incorreta. Fragilidade pode preceder incapacidade; nem toda pessoa frágil é incapaz.

Alternativa C: Correta. Polifarmácia se associa independentemente a maior risco de fragilidade em estudos observacionais.

Alternativa D: Incorreta. Déficit cognitivo não compõe os cinco componentes originais do fenótipo de Fried.

Ressalva: Fried: perda ponderal, exaustão, força reduzida, marcha lenta e baixa atividade física.

Fundamentação principal: R1.

QUESTÃO 09 | Diagnóstico de provável sarcopenia

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Sarcopenia confirmada exige comprovação de baixa quantidade/qualidade muscular.

Alternativa B: Incorreta. Não foram informados critérios suficientes do fenótipo de fragilidade.

Alternativa C: Correta. Cinco levantamentos da cadeira em 38 s indicam redução acentuada da força; pelo EWGSOP2, mais de 15 s sugere provável sarcopenia.

Alternativa D: Incorreta. O dado disponível permite suspeitar de sarcopenia com base na força, não estabelecer «provável fragilidade» como melhor classificação.

Ressalva: A imagem e o resultado do teste devem ser avaliados com suas limitações funcionais.

Fundamentação principal: R5.

QUESTÃO 10 | Confirmar sarcopenia

Gabarito técnico: D

Alternativa A: Incorreta. O teste pertinente para força manual seria preensão PALMAR, não «plantar», e a baixa força já está demonstrada.

Alternativa B: Incorreta como próximo passo para confirmação. Velocidade de marcha ajuda a estimar gravidade/desempenho, depois da confirmação por massa muscular.

Alternativa C: Incorreta. Dosagens de vitaminas não estabelecem sarcopenia.

Alternativa D: Correta. Medir quantidade/qualidade muscular (por exemplo DXA ou bioimpedância validada) confirma sarcopenia no modelo EWGSOP2.

Fundamentação principal: R5.

QUESTÃO 11 | Cicatrização por segunda intenção

Gabarito técnico: D

Alternativa A: Incorreta. Bordas diretamente aproximadas e suturadas caracterizam primeira intenção.

Alternativa B: Incorreta como característica definidora. Remodelamento ocorre nas várias modalidades de cicatrização.

Alternativa C: Incorreta. Fechamento posterior à resolução de contaminação descreve melhor fechamento primário tardio/terceira intenção.

Alternativa D: Correta. A ferida permanece aberta e cicatriza espontaneamente por granulação, contração e epitelização.

Fundamentação principal: R6.

QUESTÃO 12 | Displasia do desenvolvimento do quadril

Gabarito técnico: A*

Alternativa A: Mais adequada, mas incompleta. Barlow parte de quadril flexionado e aduzido com suave pressão posterior para identificar quadril instável/luxável; o teste de Ortolani REDUZ um quadril luxado.

Alternativa B: Incorreta. Sinal de Galeazzi pode estar ausente em luxação bilateral simétrica.

Alternativa C: Incorreta. Cirurgia pode ser necessária conforme idade, gravidade e resposta ao tratamento conservador.

Alternativa D: Incorreta. Luxação teratológica não é invariavelmente tratada com calção gessado; depende das características e intervenções realizadas.

Ressalva: O enunciado chama Barlow de teste que «detecta a luxação»; tecnicamente, ele testa a possibilidade de deslocamento de um quadril instável. A alternativa A é apenas a mais próxima.

Fundamentação principal: R7.

QUESTÃO 13 | Atendimento inicial da grande queimada

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Não prioriza via aérea e inclui analgesia IM, de absorção pouco confiável em paciente hipoperfundido.

Alternativa B: Incorreta. Embora analgesia IV e atenção à via aérea sejam importantes, soro glicosado não é a solução inicial habitual para ressuscitação de queimaduras extensas.

Alternativa C: Correta. Avaliar via aérea, obter acesso venoso, iniciar cristaloide isotônico balanceado (Ringer lactato), buscar lesões e monitorar diurese.

Alternativa D: Incorreta. Via intramuscular e antibioticoprofilaxia sistêmica rotineira não são indicadas; oxigênio deve ser adaptado ao contexto, com prioridade à via aérea.

Ressalva: O volume da reposição depende de peso, área queimada e resposta; diretriz ABA sugere iniciar em 2 mL/kg/%SCQ nas primeiras 24h para adultos ≥20% SCQ, titulando pela diurese.

Fundamentação principal: R8.

QUESTÃO 14 | Osteossarcoma

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. É neoplasia óssea maligna, não tumor benigno.

Alternativa B: Incorreta. O local habitual é metáfise de ossos longos (por exemplo, fêmur distal/tíbia proximal), não diáfise de ossos tubulares curtos.

Alternativa C: Correta. Lesão metafisária agressiva apresenta limites mal definidos, destruição óssea e reação periosteal.

Alternativa D: Incorreta. Margens nitidamente delimitadas, em regra, sugerem comportamento menos agressivo.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 15 | Escoliose torácica grave

Gabarito técnico: B

Alternativa A: Incorreta. Desnutrição por suposta redução abdominal não é consequência fundamental para identificar essa deformidade.

Alternativa B: Correta. Curva torácica de 91° provoca deformidade costovertebral tridimensional e pode reduzir volumes pulmonares.

Alternativa C: Incorreta. Ângulo de 91° é curva grave, não de pequena magnitude; necessita avaliação especializada.

Alternativa D: Incorreta. O ângulo de Cobb é parâmetro central da magnitude e do risco de progressão, embora localização e maturidade também importem.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 16 | Nervo doador em enxertia

Gabarito técnico: B

Alternativa A: Incorreta. Enxerto do nervo fibular causaria maior déficit motor/sensitivo e não é o doador clássico.

Alternativa B: Correta. Nervo sural é frequentemente usado como enxerto autólogo sensitivo por acesso e extensão apropriados.

Alternativa C: Incorreta. O safeno é sensitivo e pode ser utilizado em situações selecionadas, mas não é o mais empregado.

Alternativa D: Incorreta. O nervo auricular posterior não é doador habitual para enxertia longa; o grande auricular é alternativa em enxertos curtos.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 17 | Tumor diafisário com reação «casca de cebola»

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Osteossarcoma é em geral metafisário e costuma produzir matriz osteoide agressiva.

Alternativa B: Incorreta. Condrossarcoma predomina no adulto e costuma ser lesão de matriz cartilaginosa.

Alternativa C: Correta. Sarcoma de Ewing costuma atingir diáfise de ossos longos em jovens e pode ter periostite lamelada.

Alternativa D: Incorreta. Osteoblastoma é menos típico dessa apresentação diafisária agressiva.

Ressalva: O aspecto em «casca de cebola» não é patognomônico.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 18 | Descrição do desvio em antecurvado

Gabarito técnico: A

Alternativa A: Correta. Antecurvado significa angulação com vértice voltado anteriormente.

Alternativa B: Incorreta. Vértice medial denotaria desvio no plano frontal.

Alternativa C: Incorreta. Vértice lateral igualmente corresponde a outro plano de angulação.

Alternativa D: Incorreta. Vértice posterior caracteriza recurvato, não antecurvado.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 19 | Trauma craniofacial e proteção cervical

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Primeira prioridade é via aérea com proteção cervical e controle de hemorragia ameaçadora, não apenas avaliação da fratura facial.

Alternativa B: Incorreta. Inconsciência aumenta a necessidade de proteção da coluna até exclusão de lesão.

Alternativa C: Correta. Trauma de face, TCE, intoxicação e coma impedem excluir lesão cervical sem avaliação apropriada.

Alternativa D: Incorreta. Babinski e Hoffmann sugerem comprometimento de via piramidal, em geral acima dos segmentos lombares isolados.

Fundamentação principal: R10.

QUESTÃO 20 | Lombalgia mecânica sem sinais de alarme

Gabarito técnico: B

Alternativa A: Incorreta. Ressonância não é rotineira apenas por três meses de lombalgia, sem déficit, sinais de alerta ou falha documentada de tratamento conservador adequado.

Alternativa B: Correta. Reabilitação ativa, educação, exercício e orientações ergonômicas são tratamentos iniciais apropriados.

Alternativa C: Incorreta. AINE/miorrelaxante por seis semanas não é estratégia inicial preferencial, pelo perfil de riscos e benefício limitado.

Alternativa D: Incorreta. Ausência de irradiação e sintomas neurológicos não favorece hérnia discal sintomática como principal hipótese.

Ressalva: Se houver persistência incapacitante apesar de tratamento adequado ou novos sinais de alarme, reavaliar necessidade de imagem.

Fundamentação principal: R11.

QUESTÃO 21 | Diferenciais de dor/subacromial

Gabarito técnico: SEM ÚNICA

Alternativa A: Possível. Capsulite adesiva e tendinopatia calcária podem causar dor no ombro e compor diferencial.

Alternativa B: Possível. Instabilidade/subluxação glenoumeral e radiculopatia por hérnia cervical podem simular sintomas, conforme exame.

Alternativa C: Possível. Radiculopatia cervical é diferencial; neoplasia é menos provável, mas deve ser considerada com sinais de alarme.

Alternativa D: Possível. Ruptura do supraespinhal e artrose acromioclavicular podem produzir quadro semelhante e são diferenciais usuais.

Ressalva: A pergunta pede «diagnósticos diferenciais» sem «mais prováveis», sem dados discriminatórios e com múltiplos pares defensáveis. Não é possível validar uma única letra com rigor; a fonte sugere A, mas D também é claramente plausível.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 22 | Síndrome do idoso caidor

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Barthel=90 informa independência funcional, não critério de quedas recorrentes.

Alternativa B: Incorreta. SARC-F=6 rastreia sarcopenia, mas não define a síndrome de quedas recorrentes.

Alternativa C: Correta. Duas ou mais quedas em 12 meses apontam quedas recorrentes e exigem avaliação multifatorial.

Alternativa D: Incorreta como definição da síndrome recorrente. Queda única grave também demanda investigação, mas não caracteriza recorrência por si só.

Ressalva: Uma queda com lesão grave continua sendo indicação de avaliação e prevenção, independentemente do rótulo.

Fundamentação principal: R1.

QUESTÃO 23 | Fisioterapia na osteoporose sem fratura

Gabarito técnico: C*

Alternativa A: Incorreta como preferência exclusiva. Hidroterapia ajuda mobilidade/equilíbrio, mas oferece menor carga osteogênica.

Alternativa B: Incorreta. Alongamentos isolados não representam estímulo suficiente de resistência óssea.

Alternativa C: Mais adequada se individualizada. Exercícios globais com carga/impacto apropriado e fortalecimento contribuem para a manutenção óssea.

Alternativa D: Menos adequada como regra absoluta. Fortalecimento sem impacto pode ser útil, mas não precisa excluir estímulo osteogênico seguro.

Ressalva: «Com impacto» não significa impacto alto indiscriminado. Intensidade, risco de quedas/fraturas e treinamento devem ser individualizados.

Fundamentação principal: R12.

QUESTÃO 24 | Critérios e exame em fibromialgia

Gabarito técnico: D

Alternativa A: Incorreta. Termografia não é exame diagnóstico validado para fibromialgia.

Alternativa B: Incorreta. Polissonografia não diagnostica fibromialgia; pode investigar distúrbio do sono concomitante.

Alternativa C: Incorreta ou ao menos inadequada ao contexto: dor generalizada faz parte essencial dos critérios ACR 2016 e da avaliação clínica proposta.

Alternativa D: Correta. Pontos dolorosos podem auxiliar exame e avaliação em conjunto com fadiga, sono não reparador e sintomas funcionais, embora não sejam obrigatórios.

Ressalva: As diretrizes de 2017 não tornam a contagem de tender points condição indispensável.

Fundamentação principal: R13.

QUESTÃO 25 | T-score escrito como +2,9

Gabarito técnico: D*

Alternativa A: Incorreta. Osteopenia corresponde ao intervalo entre −1,0 e −2,5, não a +2,9.

Alternativa B: Incorreta conforme redação literal. Osteoporose densitométrica exige T-score ≤ −2,5; seria a letra correta se o valor fosse −2,9.

Alternativa C: Incorreta. «Massa óssea para idade» é usualmente avaliada pelo Z-score, principalmente em adultos jovens.

Alternativa D: Correta se o enunciado for literal. Um T-score de +2,9 indica densidade óssea acima da média de referência e não preenche osteoporose.

Ressalva: QUESTÃO COM POSSÍVEL ERRO DE SINAL. O PDF informa «t-score de 2.9» sem sinal negativo. Não é lícito pressupor −2,9; portanto, gabarito técnico literal D e possível intenção B.

Fundamentação principal: R14.

QUESTÃO 26 | Manobra de Patrick-FABER

Gabarito técnico: A

Alternativa A: Correta. FABER significa flexão, abdução e rotação externa.

Alternativa B: Incorreta. Extensão e rotação interna não constituem FABER.

Alternativa C: Incorreta. Repete a descrição de extensão e rotação interna, que não corresponde ao teste.

Alternativa D: Incorreta. O teste requer abdução, não adução.

Ressalva: O teste provoca dor que pode ser sacroilíaca ou do quadril; resultado isolado não diagnostica sacroileíte.

Fundamentação principal: R15.

QUESTÃO 27 | Síndrome de Sjögren

Gabarito técnico: B

Alternativa A: Incorreta como melhor hipótese. Artrite reumatoide pode cursar com sicca secundária, mas xeroftalmia/xerostomia e anti-Ro/La favorecem Sjögren.

Alternativa B: Correta. Sicca ocular e oral mais anti-SSA/Ro e anti-SSB/La sustentam síndrome de Sjögren, embora a classificação exija avaliação objetiva.

Alternativa C: Incorreta. Não há psoríase, dactilite ou padrão clínico compatível como hipótese principal.

Alternativa D: Incorreta. Osteoartrite não explica autoanticorpos SSA/SSB ou queixas secretórias.

Ressalva: FR positivo é inespecífico; pode ocorrer em Sjögren. A expressão «títulos 1:280» não corresponde necessariamente à unidade padronizada de todos os imunoensaios.

Fundamentação principal: R16.

QUESTÃO 28 | Tratamento da crise aguda de gota

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Condrocalcinose aponta deposição de pirofosfato de cálcio, não artrite reumatoide.

Alternativa B: Incorreta. Erosões em «saca-bocado» são típicas da gota tofácea crônica, não osteoartrite.

Alternativa C: Correta. Colchicina ou AINE, como diclofenaco se não houver contraindicação, podem tratar crise de gota; também se pode usar corticosteroide.

Alternativa D: Incorreta como resposta à inflamação aguda. Alopurinol/benzbromarona reduzem urato, mas não substituem anti-inflamatórios para controlar a crise.

Ressalva: Pode-se iniciar terapia redutora de urato durante a crise em indicação adequada, com anti-inflamatório concomitante; não se exige adiá-la sempre.

Fundamentação principal: R17.

QUESTÃO 29 | Diagnósticos diferenciais de poliartrite aguda

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Osteoartrite é pouco compatível com 4 semanas de poliartrite inflamatória simétrica, febre e FAN alto.

Alternativa B: Incorreta. Inclui osteoartrite e omite LES, hipótese forte por úlceras orais e possível envolvimento renal.

Alternativa C: Correta como conjunto. LES, artrite viral e gonocócica devem ser contempladas diante de FAN alto, úlceras, disúria e relação sexual sem proteção.

Alternativa D: Menos adequada. AR e artrite gonocócica são possíveis, mas artrite psoriásica não é sustentada e LES fica de fora.

Ressalva: O envolvimento renal deve ser esclarecido com urina tipo I, relação proteína/creatinina e função renal; FAN isolado não confirma LES.

Fundamentação principal: R16.

QUESTÃO 30 | Exames para poliartrite com suspeita de LES

Gabarito técnico: D*

Alternativa A: Incorreta como prioridade. Ácido úrico não explica o padrão inflamatório descrito, embora mensurar proteína urinária seja relevante.

Alternativa B: Incorreta como prioridade. Anti-CCP pode auxiliar hipótese de AR, porém RM de mãos não é o primeiro exame diante de provável doença sistêmica renal.

Alternativa C: Parcialmente pertinente. Artrocentese pode ser essencial se houver suspeita de artrite infecciosa, e sorologias para HIV/hepatites/arboviroses podem integrar investigação.

Alternativa D: Mais adequada ao conjunto. Anti-dsDNA e quantificação da proteinúria ajudam a investigar LES com possível nefrite.

Ressalva: D não exclui a necessidade de investigar gonococo/IST e descartar artrite séptica, conforme achados; C também tem valor clínico, mas D é melhor entre as opções.

Fundamentação principal: R16.

QUESTÃO 31 | Identificar os quatro imunomoduladores

Sem opção por letra: I = ciclosporina; II = azatioprina; III = sulfassalazina; IV = tacrolimo

Afirmativa I: Ciclosporina: imunossupressor peptídico cíclico, inibidor da calcineurina e da transcrição de IL-2. A menção à inibição de «receptores IL-1/IL-2» é farmacologicamente imprecisa.

Afirmativa II: Azatioprina: pró-fármaco de 6-mercaptopurina, interfere na síntese de purinas e pode causar mielossupressão.

Afirmativa III: Sulfassalazina: é degradada em sulfapiridina e ácido 5-aminossalicílico; DMARD sintético convencional.

Afirmativa IV: Tacrolimo: macrolídeo imunossupressor produzido por Streptomyces, com inibição da calcineurina similar à ciclosporina.

Ressalva: ALTERNATIVAS A-D NÃO FORAM ANOTADAS NO DOCUMENTO. Não há como atribuir uma letra verificável. Correspondência: I ciclosporina; II azatioprina; III sulfassalazina; IV tacrolimo.

Fundamentação principal: R18.

QUESTÃO 32 | Mecanismo e propriedades dos AINEs

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Efeitos usuais são analgesia, antitermia e ação anti-inflamatória; podem aumentar pressão arterial.

Alternativa B: Incorreta. Naproxeno tem eficácia clínica demonstrada; não é 20 vezes menos potente a ponto de se tornar ineficaz.

Alternativa C: Correta. A maioria dos AINEs tradicionais inibe COX-1 e COX-2, com diferenças de seletividade/potência.

Alternativa D: Incorreta. Paracetamol é analgésico e antitérmico, com pouca atividade anti-inflamatória periférica.

Fundamentação principal: R18.

QUESTÃO 33 | Glucocorticoides: afirmativas, sem letras

Itens I e II verdadeiros; III falso. Sem opções por letra no original.

Afirmativa I: Verdadeira no sentido histórico: modificações estruturais de cortisona/hidrocortisona originaram análogos sintéticos com menor atividade mineralocorticoide.

Afirmativa II: Verdadeira como generalização para diversos análogos: é possível obter maior potência e ação prolongada, com menor retenção de sódio.

Afirmativa III: Falsa como redigida. Triancinolona não tem aproximadamente 30 vezes a potência da hidrocortisona (a equivalência usual é cerca de 5x); dexametasona/betametasona têm cerca de 25–30x. A redação do precursor «19-flurpredinisolona» também é problemática.

Ressalva: As opções de resposta por letras não foram preservadas no arquivo; apresenta-se o julgamento das três afirmações, sem inventar correspondência.

Fundamentação principal: R19.

QUESTÃO 34 | Correspondência entre doença e autoanticorpos

Gabarito técnico: D

Alternativa A: Incorreta. Embora associe LES a anticorpos específicos e lúpus farmacológico a anti-histona, associa granulomatose com poliangiíte a autoanticorpos de miosite (item 2).

Alternativa B: Incorreta. Atribui à esclerose sistêmica anticorpos que não são a associação típica e erra diversas correspondências.

Alternativa C: Incorreta. Mapeia lúpus induzido por drogas para marcadores antifosfolípides e esclerose para marcadores de miosite.

Alternativa D: Correta. A-3 (LES), B-5 (lúpus induzido), C-1 (esclerose), D-2 (miosites), E-4 (Sjögren), F-7 (SAF), G-6 (GPA/ANCA-PR3).

Alternativa E: Incorreta. Troca LES por anti-histona e incorre em outras associações inadequadas.

Ressalva: A questão foi apresentada em fotografia contendo anotações manuscritas; a classificação acima foi conferida pelo conteúdo médico dos pares, não pelas marcações.

Fundamentação principal: R16.

QUESTÃO 35 | Anemia no idoso: julgar afirmações

Apenas II inequivocamente correta (ver ressalva ao item IV)

Afirmativa I: Falsa. Ferro sérico isolado flutua e costuma ser baixo também na anemia da inflamação; tem poder discriminatório limitado.

Afirmativa II: Verdadeira com ressalvas. Ferritina é marcador de primeira linha da deficiência de ferro; inflamação pode elevá-la artificialmente, exigindo saturação de transferrina e avaliação do contexto.

Afirmativa III: Falsa. Reticulócitos avaliam resposta medular, sem distinguir de modo confiável ferropriva de megaloblástica.

Afirmativa IV: Não recomendável como obrigação diagnóstica. Em idoso com anemia ferropriva, pesquisa de sangue oculto não substitui avaliação etiológica, frequentemente com endoscopia bidirecional.

Ressalva: O gabarito antigo aponta II+IV. Pelas recomendações atuais, «sangue oculto deve ser solicitado» não é exigência adequada e teste negativo não exclui sangramento gastrointestinal. Classifico somente II como inequivocamente correta.

Fundamentação principal: R20.

QUESTÃO 36 | Padrões FAN HEp-2 e autoanticorpos

Gabarito técnico: E*

Alternativa A: Incorreta. Não respeita o pareamento padrão nuclear periférico/anti-lâmina, nem homogêneo/anti-DNA-histona.

Alternativa B: Incorreta. Atribui à configuração centromérica autoantígeno que não é anticentrômero.

Alternativa C: Incorreta. Erra combinações para pontilhado denso e padrão nuclear periférico.

Alternativa D: Incorreta. Confunde os padrões homogêneo e periférico e/ou associações de granularidade.

Alternativa E: Mais provável. Pela parte legível: I-4 (periférico/anti-lâmina), II-2 (homogêneo/anti-DNA-histona), III-5 (centromérico), IV-1 (pontilhado fino denso/DFS70), V-6 (grosso/Sm-RNP), VI-3 (fino/SSA-SSB).

Ressalva: A fotografia original corta trechos laterais da alternativa E; a sequência final é inferida da correspondência técnica dos seis padrões e deve ser tratada como PROVÁVEL, não leitura integral da opção.

Fundamentação principal: R21.

QUESTÃO 37 | Lesão epifisária lítica de tíbia

Gabarito técnico: D*

Alternativa A: Possível. Tumor de células gigantes é tipicamente epifisário, em adulto jovem, lítico e às vezes hemorrágico.

Alternativa B: Possível. Cisto ósseo aneurismático pode apresentar cavidades sanguinolentas e células gigantes.

Alternativa C: Possível. Tumor marrom do hiperparatireoidismo contém células gigantes e hemorragia, embora deva ser correlacionado com PTH/cálcio.

Alternativa D: Menos provável pela descrição da imagem. Osteossarcoma osteoblástico convencional tende a ter imagem agressiva e margens não nítidas.

Ressalva: A referência a «tecido osteóide» é inespecífica sem descrição de osteoide neoplásico maligno. Se houver osteoide produzido por células malignas, osteossarcoma ganha peso; exige histopatologia.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 38 | Características dos sarcomas

Gabarito técnico: A

Alternativa A: Correta, entendendo-se sarcoma retroperitoneal. O crescimento em espaço profundo permite volume grande antes de sintomas e diagnóstico tardio.

Alternativa B: Incorreta. Sarcomas em conjunto afetam várias idades e não são, como grupo, mais frequentes em crianças do que em adultos.

Alternativa C: Incorreta. A disseminação habitual dos sarcomas de partes moles é hematogênica; linfonodos são menos frequentes, salvo subtipos.

Alternativa D: Incorreta. O pulmão é sítio clássico de metástase hematogênica, não o cérebro.

Ressalva: O enunciado diz «peritônio» em vez de «retroperitônio», provavelmente pretendendo essa localização anatômica.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 39 | Nódulos superficiais da coxa

Gabarito técnico: A*

Alternativa A: Mais provável. Lipomas são tumores benignos comuns no subcutâneo e podem ser múltiplos.

Alternativa B: Menos provável. Hemangiomas/lesões vasculares podem ser múltiplos, mas costumam apresentar características vasculares na imagem e exame.

Alternativa C: Menos provável epidemiologicamente. Rabdomiossarcoma é raro aos 60 anos e costuma levantar suspeita por massa crescente.

Alternativa D: Incorreta. Osteoma é tumor ósseo, incompatível com múltiplos nódulos subcutâneos não relacionados ao osso.

Ressalva: Tamanho de cerca de 5 cm exige análise criteriosa, sobretudo se houver crescimento, consistência atípica ou achados suspeitos; sem exame de imagem detalhado não há diagnóstico definitivo.

Fundamentação principal: R9.

QUESTÃO 40 | Radiografia de osteoartrite

Gabarito técnico: B

Alternativa A: Incorreta. Osteopenia justa-articular é mais típica de artrites inflamatórias, como AR.

Alternativa B: Correta. Osteófitos, redução do espaço articular e esclerose subcondral favorecem osteoartrite.

Alternativa C: Incorreta. Sinovite pode coexistir, mas erosões marginais são mais típicas de artrites inflamatórias.

Alternativa D: Incorreta. Geno varo ou valgo pode aumentar e resultar de sobrecarga assimétrica no joelho com osteoartrite.

Fundamentação principal: R22.

QUESTÃO 41 | Osteomielite: achados radiológicos

Gabarito técnico: C

Alternativa A: Incorreta. Abscesso de Brodie é forma localizada subaguda, não marcador do estágio agudo clássico.

Alternativa B: Incorreta como regra. Abscesso de Brodie costuma ser intramedular, frequentemente metafisário, embora haja localização cortical ocasional.

Alternativa C: Correta. Sequestro é fragmento ósseo desvitalizado separado do osso viável, característico de osteomielite crônica.

Alternativa D: Incorreta. Reação periosteal ocorre em infecção, tumor e trauma; não é patognomônica.

Fundamentação principal: R23.

QUESTÃO 42 | Osteomielite: identificar alternativa incorreta

Gabarito técnico: A

Alternativa A: Incorreta, portanto é a resposta. Radiografia convencional costuma não exibir lise osteomielítica nas primeiras 24h; alterações ósseas são tardias.

Alternativa B: Correta em geral, com ressalva. Metáfises são foco comum em crianças; fise aberta pode limitar disseminação para epífise, mas não é barreira absoluta.

Alternativa C: Correta em princípio. Focos infecciosos à distância podem causar bacteremia e semeadura hematogênica óssea.

Alternativa D: Aceitável apenas de modo contextual. S. aureus é predominante; bacilos gram-negativos como E. coli, Pseudomonas e Proteus aparecem sobretudo em grupos/rotas específicos, não como quartetos universalmente «mais frequentes».

Ressalva: Embora A seja claramente falsa, a generalização de D também é criticável. A resposta mais segura para «incorreta» é A.

Fundamentação principal: R23.

Referências bibliográficas para conferência

As fontes abaixo embasam a revisão técnica e contextualizam divergências com a prova de 2019. Não substituem avaliação médica individual. Algumas referências tratam do domínio clínico da questão, não necessariamente de cada afirmação específica.

R1. NICE: avaliação multifatorial e prevenção de quedas (NG249, 2025); referencial geral de geriatria
https://www.nice.org.uk/guidance/ng249/chapter/Recommendations

R2. Cuidados paliativos em doença grave: recomendações e tomada de decisão compartilhada
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

R3. American Geriatrics Society. Feeding tubes in advanced dementia: position statement (2014)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25039796/

R4. American Geriatrics Society. 2023 AGS Beers Criteria (atualização)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12478568/

R5. Cruz-Jentoft et al. Sarcopenia: revised European consensus EWGSOP2 (2019)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6322506/

R6. StatPearls. Wound Healing Phases / Principles of wound management
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535406/

R7. AAFP. Developmental Dysplasia of the Hip: Barlow and Ortolani
https://www.aafp.org/afp/2006/1015/p1310

R8. American Burn Association. Clinical Practice Guidelines on Burn Shock Resuscitation (2024)
https://academic.oup.com/jbcr/article/45/3/565/7458089

R9. AAFP. Bone Cancer: Diagnosis and Treatment Principles (2018); apoio à oncologia óssea
https://www.aafp.org/afp/2018/0815/p205

R10. NICE. Spinal injury: assessment and initial management
https://www.nice.org.uk/guidance/ng41

R11. AAFP. Chronic low back pain in adults: evaluation and management (2024)
https://www.aafp.org/afp/2024/0300/chronic-low-back-pain

R12. UK Consensus. Strong, steady and straight: exercise for osteoporosis (2022)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9304091/

R13. Sociedade Brasileira de Reumatologia. New guidelines for diagnosis of fibromyalgia (2017)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28800969/

R14. International Society for Clinical Densitometry (ISCD): Adult Official Positions
https://iscd.org/learn/official-positions/adult-positions/

R15. Systematic review of SI joint clinical tests, including FABER
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1924656/

R16. EULAR/ACR clinical classification and ANA patterns: ICAP clinical relevance (2019)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6585284/

R17. American College of Rheumatology. 2020 guideline for management of gout
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10563586/

R18. NCBI Bookshelf. Disease-modifying antirheumatic drugs: mechanisms
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507863/

R19. Endotext. Glucocorticoid therapy and adrenal suppression
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279156/

R20. American Gastroenterological Association. Gastrointestinal evaluation of iron deficiency anemia (2020)
https://gastro.org/clinical-guidance/gastrointestinal-evaluation-of-iron-deficiency-anemia/

R21. International Consensus on ANA Patterns (ICAP), padrões AC-1/2/3/4/5
https://www.anapatterns.org/

R22. ACR/Arthritis Foundation. Osteoarthritis management guideline (2019)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10518852/

R23. NCBI Bookshelf. Osteomyelitis: imaging, pathogenesis and management
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK594242/?report=printable

Nota metodológica: a folha intitulada “GABARITO” existente no PDF recebido não foi utilizada para decidir respostas e não integra o PDF entregue. Todas as imagens originais das questões permanecem nas primeiras páginas.